



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سومية على محمد عبدالعال

العنوان : 24 ش عبد الفتاح عزب

زين بولاق الدكرور الجيزة

الحي / المدينة : بولاق الدكرور

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

رقم البطاقة : 27304132100781 رقم التليفون : 01157371355

العمر (تاريخ الميلاد) : 13-04-1973 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي بعقار (Capecitabine 500mg) قسم العلاج : الاورام [14149]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سومية علي محمد عبدالعال National ID: 27304132100781	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Capecitabine therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سومية
علي محمد عبدالعال
٢١ من عبدالفتاح عزيب - زنوب
بولاق الدكرور - الجيزة

١٩٧٣/٠٤/١٣ ٢٧٣٠٤١٣٢١٠٠٧٨١

IF0101287



٢٠١٩/١٠ ٢٧٣٠٤١٣٢١٠٠٧٨١

ربة منزل

متزوجة
مسلمة
أنثى
عبدالقادر بركات عويس عبدالقادر
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/١٠/١١





Ministry of Health and Wellness
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة
والرفاهية



A Patient ID

1- Number 1

2- Number

MDT form

3- Medical number

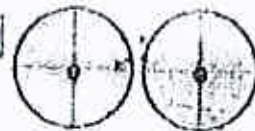
Female

5224450

U-3 Med

4045-2024

Patient Age: 52.1



Family history

Family history

Phone

01152371355

SHL

REASON OF MD

Reason of MD

Medical status

Medical status

NBS Score

NBS Score

GROUP

Date of MD

Date of MD

Comorbidity

Comorbidity

Menopausal status

Menopausal status

Initial stage

Initial stage

21/17/2024

Clinical data					
Breast Imaging 1			Mets Workup 1		
DX	ER	PR	Her 2 Neu	SI50	KI67
10C	8/8	8/8	0	15%	15%

1	N	M
2	2	0 BY CT

Sonogram/mammography

PATIENT HISTORY

10/2024 RT MRM ---> pT2-N2(5/14) M0 BY CT CAP

ECHO

LABS

BONE SCAN ---> REQUESTED

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJ AC X4, TXT X4

PORT

ADJ A1 X7 YRS

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition
SURGERY			
Psychiatric			

Patient Name: Somaiah Ali Mohammed
Prof. Dr: Ahmed El-Khateeb
Accession: 241024-417

Patient ID: 65547
Exam Date: 26/10/2024

Bilateral digital Mammography and Complementary Ultrasound Examination

- Scattered fibroglandular densities of both breasts (ACR b) with right breast UIQ spiculated mass with internal suspicious micro calcifications along with anterior and posterior long spicules by U/S : showed ill-defined heterogeneous mass is seen at 2 o'clock para areolar measuring about 40x36 mm with internal vascularity on color Doppler causing dimpling to the skin and retracted nipple ..As well as ipsilateral distorted lymph node is seen at internal mammary chain at the mid line of sternum measuring 12x14.5 mm
- Normal skin thickness and contour of LT breast.
- Normal nipple areola complexes of left breast.
- LT breast No dilated retroareolar ducts
- Left breast: No solid or cystic mass lesions.
- Bilateral non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

CONCLUSION:

- Right breast malignant mass as described and internal mammary chain pathological lymph node for biopsy (BIRADS 5)
- Left breast mild adenosis (BIRADS 2)

Best regards;
Dr Mahetab Afifi, Msc, FEBR

Definition of Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS)

<u>Category</u>	<u>Definition</u>
BIRADS 0	Non informative study
BIRADS 1	Normal study
BIRADS 2	Benign lesion
BIRADS 3	Probably benign lesion
BIRADS 4	Probably malignant lesion (A: mild suspicion, B: moderate suspicion, C: high suspicion)
BIRADS 5	Malignant lesion
BIRADS 6	Pathologically proved malignant lesion



Patient Name: Somaya Ali Mohamed Abd Al Aal	Date : 20/10/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 4045/2024	Pat. ID: 94392

LEFT MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after right mastectomy, chemotherapy and radiotherapy .

- **Breast density:** Scattered areas of fibroglandular tissue ... **Matching ACR b.**
- No detected suspicious mass density or architectural distortion.
- No detected pathological micro-calcification.
- Normal skin and nipple.

Complementary breast ultrasound revealed:

- **Clear operative bed with no residue or recurrence.**
- **Post therapeutic changes in form of diffuse skin thickening**
- **Mixed fatty and glandular parenchyma of the left breast.**
- **No detected suspicious solid or cystic masses.**
- No dilated ducts.
- Normal skin and nipple.
- Few enlarged axillary lymph nodes showing oval shape and preserved fatty hilum... **Reactive.**

CONCLUSION:

- **Clear operative bed with No detected tumor residue or recurrenc.**
- **Normal left breast BI-RADS 1 category.**

Dr farah elshobaky

PATIENT'S NAME: سومية علي محمد

AGE: 53Y

SEX: F

REFERRED BY PROF. DR.: Ahmed Al Khateeb

CLINICAL DIAGNOSIS: Rt. breast multicentric lesions

NATURE OF THE SPECIMEN: Right MRM.

SPECIMEN OBTAINED AT: 31/10/2024

SPECIMEN REPORTED AT: 3/11/2024

PATHOLOGY REPORT

GROSS: MRM, breast tissue measured 25x20x9cm., covered by skin ellipse 16x10cm. including inverted nipple & areola, the deep surface showed muscle tissue 5x2cm. Attached axillary fat was 10x8cm. Serial sections revealed 2 irregular solid firm to hard grayish white masses; one retroareolar 3.5x3cm. and one adherent to the submitted muscle 1.5x1.5cm. *Axillary fat was including 14 lymph nodes, the largest was 3x2cm.

MICROSCOPY: Sections examined from the breast 2 masses revealed malignant neoplastic growth composed of invasive cords, clusters and tubules of moderately anaplastic ductal epithelial cells infiltrating base of nipple, 10% in situ component supported by desmoplastic stroma with mild lymphocytic infiltrate about 5%. Lymphatic tumor emboli & perineural invasion were seen. The nipple, areola & resection margins were free. The axillary lymph nodes showed heavy metastatic deposits in 5/14 with extracapsular extension.

DIAGNOSIS: RIGHT MRM:

- MULTICENTERIC INVASIVE DUCT CARCINOMA GRADE 2, REACHING BASE OF NIPPLE, 10% DCIS, POSITIVE PERINEURAL INVASION & LYMPHATIC TUMOR EMBOLI.
- FREE SKIN OF NIPPLE, AREOLA & RESECTION MARGINS.
- POSITIVE 5/14 AXILLARY LYMPH NODES, EXTRACAPSULAR EXTENSION.
- STAGE; pT2 (m) N2 (MAXIMUM TUMOR DIMENSION 3.5cm).

N.B: ER, PR, Her2-neu and ki67 immunostains are available on request

NB: Four slides enclosed
Thank for reference

SIGNATURE

DR. AMAL HAREEDY, MD

Name : Soumia Ali Mohammed Abdul-Aal

Date : 15-09-2025 09:35

Branch : Dokki

Medical No. : 202563

Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- A 52-year-old lady, with history of right breast cancer.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions could be seen over the surveyed skeleton to account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine